
照护者叙事 · 第十二期

记忆退去时,我们如何守住尊严

一位女儿与母亲共同面对遗忘的两年

撰稿:家庭照护小组

本次汇报

01

疾病负担

流行病学与现状

02

诊疗路径

从识别到干预

03

关键指标

疗效与安全

04

现存问题

瓶颈与风险

05

改进方案

下一步计划

06

资源需求

投入与时间表

· CHAPTER ·

01

疾病负担

阿尔茨海默病AD的流行病学与临床现状

“

早识别、早干预，
是改变阿尔茨海默病AD结局的关键

时间窗决定神经功能的可挽救程度

阿尔茨海默病 AD 的四步管理

早期识别 —— 基于典型症状与量表快速筛查

□ □ □ □ —— 影像 + 电生理 + 抗体检测

规范治疗 —— 急性期干预与长期维持并重

□ □ □ □ —— 功能评估与并发症防控

* 路径依据最新专家共识

发病机制与干预靶点

病理基础

- 神经元/髓鞘损伤
- 炎症与免疫异常
- 神经环路受累

关键指标(示例)

onset : 急性/亚急性
target : 免疫调节
window : 4.5h
score : mRS 0-2

综合管理的三个维度

A

急性期

快速稳定,把握可逆的治疗时间窗

B

维持期

预防复发,控制疾病活动度

C

康复期

功能重建与生活质量提升

规范化管理前后

干预前

分散诊疗

- 识别延迟
- 路径不统一
- 随访脱节

干预后

闭环管理

- 快速通道
- 标准路径
- 全程随访

典型影像表现

阿尔茨海默病 AD在 MRI/CT 上有其特征性征象,是确诊与分型的重要依据。规范化的影像采集与判读流程,能显著提升诊断一致性。

此处放置影像图

“影像必须结合临床与实验室,单一征象不足以定论。”

— 诊断规范

本年度诊疗数据

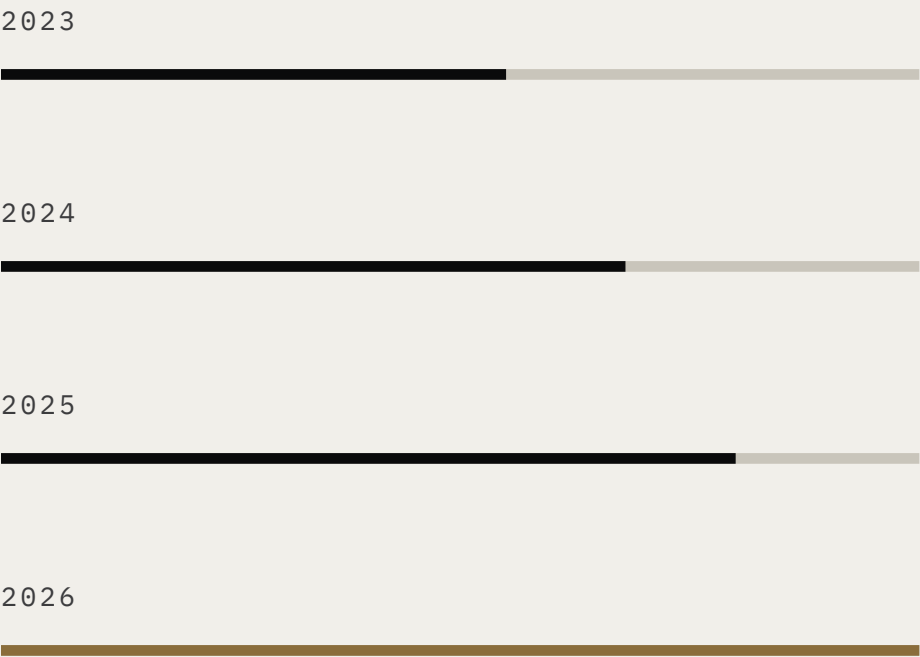
年接诊量	确诊时间	规范治疗率	年复发率
1,240 例	3.2 天	91 %	12 %
↑ 18%	↓ 0.8 天	↑ 6 pt	↓ 3 pt

阿尔茨海默病 AD 的核心疗效指标

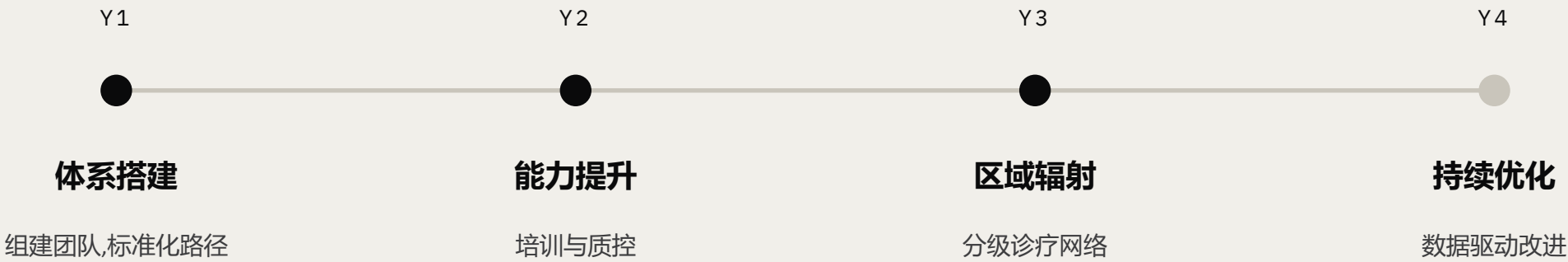
10 年

从确诊到晚期的平均病程

早期干预与照护规划,决定了这段旅程的质量。



三年建设时间线

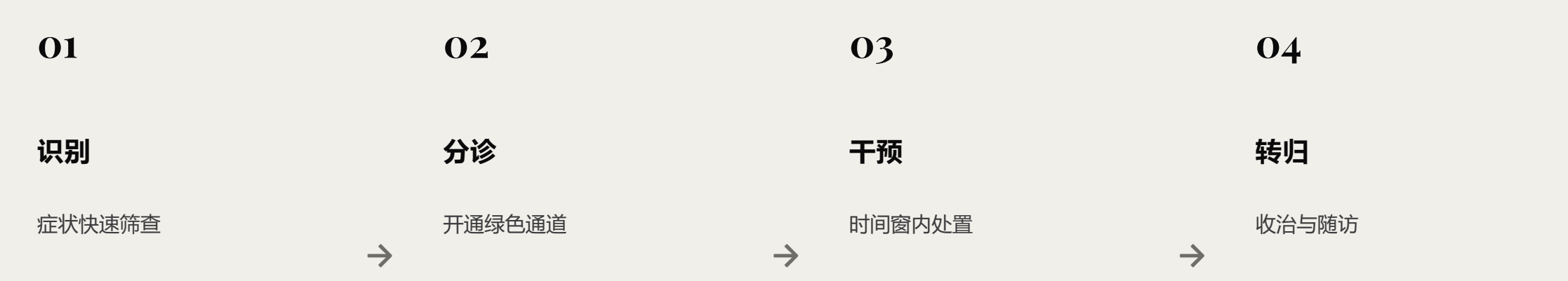


分型与治疗方案

分型	占比	一线方案	预后
经典型	62%	标准治疗	良好
进展型	24%	强化方案	中等
难治型	14%	个体化	需随访

来源：科室登记数据 2026

急救绿色通道



总结 · NEXT

让每一位阿尔茨海默病患者都得到规范诊疗

照护者手记

推进标准化路径落地
